

¹И.Н. Ли, ¹Д.Г. Букин, ²Э.Н.Бейсебаев¹ФАО «Железнодорожные Госпитали Медицины Катастроф²Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова

Результаты комплексного лечения рака молочной железы

Аннотация. В статье даны результаты комплексного лечения больных местно-распространенным раком молочной железы. Достоверно значимое повышение патоморфоза на 17,6% в основной группе. Повышение показателей общей и безрецидивной выживаемости на 5% и 10,9% соответственно.

Ключевые слова: местно-распространенный рак молочной железы, хирургическое лечение, общая, безрецидивная выживаемость.

Актуальность

В Республике Казахстан в структуре онкологической заболеваемости и смертности всего населения рак молочной железы (РМЖ) так же, как и в экономически развитых странах мира занимает первое место (12,3%). При этом интенсивный показатель заболеваемости РМЖ в 2012 г. составил 55,4% на 100 тыс. женского населения, а стандартизированный показатель - 22,3% на 100 тыс., что в абсолютных числах составляет 3 951 новых случая. По смертности рак молочной железы занимает третье место после рака легкого и желудка (8,4%) [1].

В диагностике РМЖ достигнуты значительные успехи, однако, несмотря на это, около 40%, заболевших выявляются с местно-распространенными формами заболевания. Современная биологическая концепция рассматривает РМЖ как системный процесс, при котором местный рост и генерализация опухоли происходят практически одновременно. Более чем у половины больных РМЖ с самого начала имеет место агрессивное течение заболевания, при котором опухоли размером до 1 см могут сопровождаться обширным метастазированием.

Внедрение в последние десятилетия в онкологическую практику значительного количества новых цитостатиков и гормональных препаратов позволило добиться улучшения непосредственных результатов лечения больных РМЖ [2-7].

Улучшение выживаемости является результатом как ранней диагностики и скрининга рака молочной железы, так и значительного прогресса в лечении этой патологии, особенно на ранних стадиях. Повсеместное и быстрое распространение рака молочной железы поставило целый ряд научных задач, среди которых важнейшими являются две: своевременное распознавание этого грозного заболевания и разработка таких методов лечения, которые бы обеспечивали длительное излечение и сохранение качества жизни пациентов.

Одним из направлений, позволяющих надеяться на улучшение результатов лечения прогностически неблагоприятных форм РМЖ, является индивидуализация химиотерапии. В связи с этим разработанный способ лечения больных операбельным РМЖ с неблагоприятным прогнозом, предполагающий использование системной

химиотерапии в сочетании с таргетной терапией как одного из компонентов, позволяет увеличить безрецидивный период и продолжительность жизни больных с II-III стадиями РМЖ, имеющих неблагоприятный прогноз.

Цель исследования

– оценить результаты комплексного лечения местно-распространенных форм рака молочной железы.

Материал и методы исследования

В исследование включены 152 больные раком молочной железы стадии T₁₋₄N₀₋₃, которые находились на лечении в КазНИИ онкологии и радиологии в период 2007-2012 годы. Основную группу составили пациентки с включением в лечение таксановых препаратов и герцептина, контролем послужили больные, получившие лечение по стандартной FAC – схеме.

Возраст больных колебался от 29 до 72 лет, средний возраст составил (48,66±7,67) лет.

Статистический анализ полученных клинических данных проводили на персональном компьютере с использованием программы "SPSS" (v 12.0 for Windows). Для определения достоверности различия в сравнительных группах использовался t-критерий Стьюдента. Выживаемость рассчитывалась методом Kaplan-Meier, различия оценивались long-rank тестом.

В следующих ниже таблицах дано распределение больных по стадиям, результатам ИГХ-исследования.

Таблица 1 - Распределение больных по стадиям заболевания

Стадии	Основная группа	Контрольная группа
T ₂₋₄ N ₀	14 (23,3 ± 5,4)%	17 (18,5 ± 4,0)%
T ₂₋₄ N ₁	25 (41,7 ± 6,4)%	49 (53,3 ± 5,2)%
T ₁₋₄ N ₂	12 (20,0 ± 5,2)%	21 (22,8 ± 4,4)%
T ₂₋₃ N ₃	9 (10,0 ± 3,9)%	5 (5,4 ± 2,4)%
Всего	60 (100)%	92 (100)%

Таблица 2 - Распределение больных по результатам ИГХ

Фенотипы РМЖ	Основная группа	Контрольная группа
Люминальный А тип	18 (30,1 ± 5,9)%	47 (51,2 ± 5,2)%
Люминальный В тип	14 (23,3 ± 5,4)%	12 (13,0 ± 3,5)%
Базальный тип	14 (23,3 ± 5,4)%	21 (22,8 ± 4,4)%
Her2 позитивный	14 (23,3 ± 5,4)%	12 (13,0 ± 3,5)%
Всего	60 (100)%	92 (100)%

Результаты

Непосредственные результаты проведенной химиотерапии изложены в статье [8].

Хирургическое лечение было проведено всем больным в различных объемах (таблица 3). Большую часть занимали

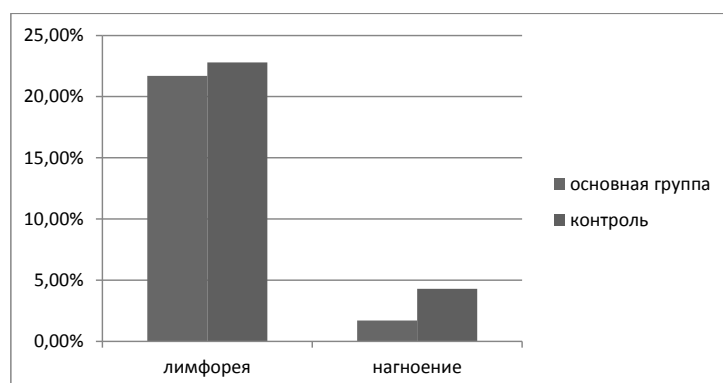


Рисунок 1 - Послеоперационные осложнения

калечащие операции по 81,6% и 73,9% в основной и контрольной группах соответственно. Для достижения операбельности процесса 4 пациенткам контрольной и 1 пациентке основной групп было проведено по 6 курсов НАПХТ, а также 1 пациентке контрольной группы было проведено 8 курсов неоадьювантной химиотерапии. Повышения выраженности и частоты побочных действий при этом не наблюдалось.

Таблица 3 - Объем оперативных вмешательств

Группа	Основная	Контрольная
РМЭ	49 (81,6±5,0)%	68 (73,9±4,6)%
ОСО	7 (11,7±4,1)%	13 (14,2±3,6)%
РМЭ + TRAM	3 (5,0±2,8)%	5 (5,4±2,4)%
РМЭ + ТДЛ с имплантатом	1 (1,7±1,7)%	6 (6,5±2,6)%
Всего	60 (100)%	92 (100)%

Из ранних послеоперационных осложнений наблюдались длительная лимфорея у 21 (22,8±4,4%) женщин контрольной и у 13 (21,7±5,3%) пациенток основной групп. Нагноение послеоперационной раны как следствие снижения иммунитета в результате получения 6 курсов НАПХТ и длительной лимфорей – в 4 (4,3±2,1%) и 1 (1,7±1,7%) случаях в контрольной и основной группах соответственно (рисунок 1).

С целью оценки эффективности была проанализирована степень лекарственного повреждения опухолевых клеток.

Таблица 4 - Степень лекарственного патоморфоза

Степень патоморфоза	0	I	II	III	IV
Группа					
Основная	7 (11,7±4,1)%	12* (20±5,2)%	18 (30±5,9)%	9 (15±4,6)%	14** (23,3±5,4)%
Контроль	8 (8,7±2,9)%	40* (43,5±5,2)%	25 (27,2±4,6)%	11 (11,9±3,4)%	8** (8,7±2,9)%

Примечание: *0,002<p<0,001, **0,02<p<0,01

Таблица 5 - Степень патоморфоза в зависимости от схемы лечения

Степень патоморфоза	0-I	II	III	IV
Группа				
Основная группа				
TF	6 (37,5±12,1)%	4 (25±10,8)%	3 (18,75±9,7)%	3 (18,75±9,7)%
TA	8* (28,5±8,5)%	11 (39,3±9,2)%	4 (14,3±6,6)%	5 (17,9±7,2)%
TG	5 (31,25±11,6)%	3 (18,75±9,7)%	2 (12,5±8,3)%	6** (37,5±12,1)%
Контроль	48* (52,2±5,2)%	25 (27,2±4,6)%	11 (11,9±3,4)%	8** (8,7±2,9)%

Примечание: *0,01<p<0,02, **p=0,02

В основной группе была выявлена выраженная степень патоморфоза в 68,3% случаев, в контрольной же группе была выявлена 0-I степень лекарственного патоморфоза более чем в половине 52,2% случаях (таблица 4).

Статистически значимая разница выявлена по I и IV степени повреждения опухолевых клеток. По остальным степеням разница не достоверна, но при сочетании их III-IV степени патоморфоза выявлены в 38,3% случаев в основной группе, что на 17,6% больше чем в контрольной группе (p=0,02). В то же время отсутствие ответа опухоли на НАПХТ (0-I степени патоморфоза) было выше в контрольной группе на 20,5% (p=0,01).

Нами также были проанализированы показатели патоморфоза в зависимости от схемы НАПХТ (таблица 5). Так в основной группе в подгруппах TF, TA, TG III-IV степени патоморфоза выявлены в 37,5%, 32,1% и в 50% случаях соответственно, в то время как в контрольной группе в 79,3% случаях выявлены 0-II степени повреждения опухолевых клеток. Статистически значимая разница выявлена при сравнении 0-I степени в группах TA и FAC, IV степени в группах TG и FAC. Выраженная степень лекарственного патоморфоза (III-IV) больше на 16,8%, 11,4% и 29,3% соответственно между группами TF и FAC, TA и FAC, TG и FAC. Достоверная разница (0,02<p<0,05) выявлена между группами TG и FAC. Следовательно, включение герцептина при Her+ статусе опухоли повышает непосредственный эффект лечения, при этом происходит более выраженное повреждение опухолевых клеток.

Нами были проанализированы частота возникновения местных рецидивов и отдаленных метастазов в исследуемых группах больных. В 10 (10,9±3,2%) и в 3 (5,0±2,8%) случаях контрольной и основной групп соответственно были выявлены местные рецидивы и отдаленные метастазы в различные сроки после комплексного лечения (рисунок 2). В основной группе отмечены метастазы в надключичные лимфоузлы, головной мозг и позвоночник по 1 больной (1,7%). В контрольной группе местные рецидивы – в 4 (4,3%), метастазы в головной мозг и легкие по 2 (2,2%), метастазы в надключичные лимфоузлы и контралатеральный метастаз – по 1 (1,1%) случаю.

При оценке появления рецидивов и метастазов в зависимости от фенотипа опухоли достоверно значимой разницы выявлено не было. В зависимости от стадии заболевания местные рецидивы отмечены при T₂N₁ стадиях, а отдаленные метастазы при T₃₋₄N₂₋₃ стадиях в контрольной группе. В основной группе такая же тенденция – отдаленные метастазы были отмечены при T₂₋₃N₂₋₃ стадиях, а также при опухолях высокой степени злокачественности.

Нами также были проанализированы безрецидивная и общая выживаемость в исследуемых группах. При определении безрецидивной и общей выживаемости были получены следующие данные (рисунок 3, 4).

Таким образом, общая и безрецидивная выживаемость составляет 100% и (95±2,3)% (0,02<p<0,05) и (97,8±1,9)% и (86,9±3,5)% (0,005<p<0,01) в основной и контрольной группах соответственно.

Выводы:

Хирургическое лечение проведено всем 152 больным МРРМЖ, однако для достижения операбельности процесса 5 пациенткам контрольной и 1 женщине основной групп было проведено 6 и больше курсов НАПХТ.

Статистически значимая разница в лечении выявлена по III-IV степени патоморфоза на 17,6% больше в основной группе, чем в контрольной ($p=0,02$). А отсутствие ответа опухоли на НАПХТ (0-I степени патоморфоза) было выше в контрольной группе на 20,5% ($p=0,01$).

При анализе отдельных подгрупп больных в основной группе по степени патоморфоза наиболее эффективной (III-IV) оказалась подгруппа TG (таксотер + герцептин) – на 29,3% выше, чем в контроле ($0,02 < p < 0,05$). В то же время 0-I степень выше в контроле на 23,7% по сравнению с ТА подгруппой ($0,01 < p < 0,02$).

Частота появления рецидивов заболевания оказалась выше на 5,9% в контрольной группе, при этом местные рецидивы отмечены при T_2N_1 стадиях, а отдаленные метастазы при $T_{3-4}N_{2-3}$ стадиях в контрольной группе. В основной группе такая же тенденция – отдаленные метастазы были отмечены при $T_{2-3}N_{2-3}$ стадиях, а также при опухолях высокой степени злокачественности.

Показатели общей и безрецидивной выживаемости выше в основной группе на 5% ($0,02 < p < 0,05$) и 10,9% ($0,005 < p < 0,01$) соответственно.

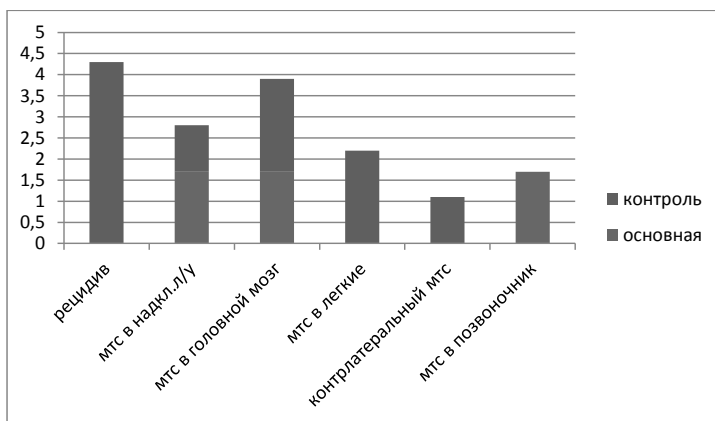


Рисунок 2 - Рецидивы и метастазы рака молочной железы

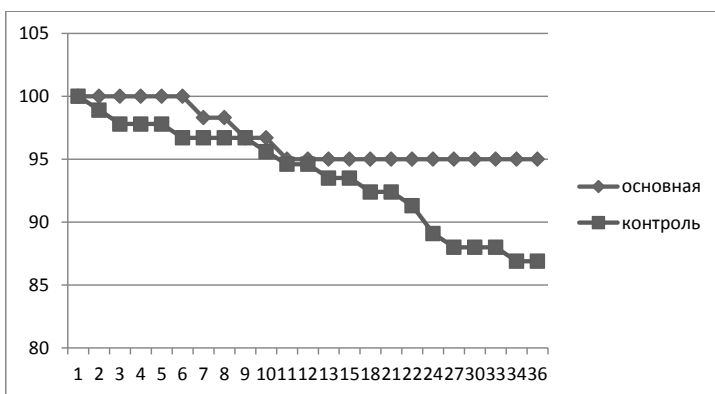


Рисунок 3 - Безрецидивная выживаемость в группах

Список литературы

1. Нургазиев Р.И., Сейтказина Г.Д., Байпеисов Д.М. и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2012 год (статистические материалы). – Алматы, 2013. – 104 с.
2. Семглазов В.Ф., Семглазов В.В., А.Божок. Таксаны в адьювантном и неоадьювантном лечении рака молочной железы // Вопросы онкологии. – 2004. – Т. 25, №2. – С. 1-8.
3. Ганьшина Л.Д. Гиперэкспрессия HER-2/neu – новые возможности в лечении рака молочной железы // Рус. мед. ж. Онкология. – 2005. – Т. 13, №13. – С. 869-874.
4. Рукерт С., Руел И., Калерт С., И.Т. Конекни. Моноклональные антитела в лечении рака молочной железы: Трастузумаб // Рус. мед. ж. Онкология. – 2005. – Т. 13, №23. – С. 1557-1566.
5. Ганьшина Н.П. Экспрессия HER-2/neu и применение Герцептина (Трастузумаба) при раке молочной железы: Автореф. дисс. к.м.н. – М., 2006. – 24 с.
6. Л.Нортон. Новые принципы цитотоксической системной терапии первичного рака молочной железы // Medi.ru. Bristol-Myers Squibb. – 2003.
7. М.Д. Стенина. Перспективные направления развития лекарственной терапии рака молочной железы // Практическая онкология. – 2002. – Т.3, №4. – С. 262-272.

Тұжырым

И.Н. Ли, Д.Г. Букин, Э.Н. Бейсебаев

АҚФ «Апаттар Медицинасының Темір Жол Госпитальдары»

С.Д. Асфендияров атындағы Қазақтың Ұлттық

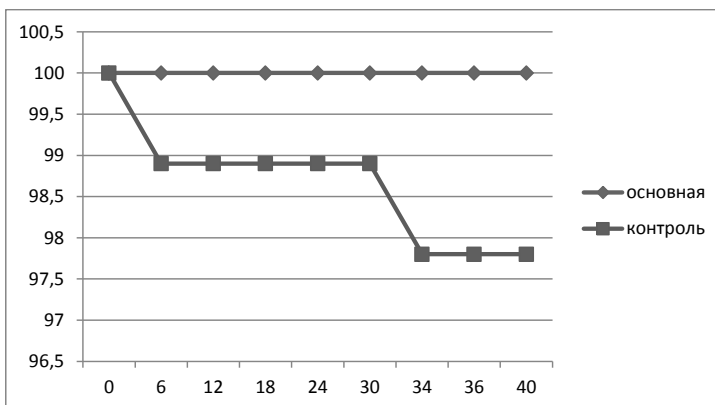


Рисунок 4 - Общая выживаемость в группах

медицина университеті.

Сүт безінің қатерлі ісігінің кешенді еміннің нәтижелері
Мақалада сүт безінің жергілікті – таралған қатерлі ісікпен ауыратын науқастардың кешенді еміннің нәтижесі берілген. Негізгі топта патоморфоз 17,6% - га айқын жоғарылаған. Жалпы және рецидивсіз өмір сүрудің көрсеткіштері 5% және 10,9% - га сәйкес жоғарылаған.

Түйінді сөздер: кешенді ем, сүт безінің қатерлі ісігі, жалпы және рецидивсіз өмір сүру.

Summary

I.N. Li, D.G. Burin, I.N. Beisebaev

“Railway Hospitals of Disaster Medicine”

Kazakh National Medical University im.S.D.Asfendiyarova,

*THE RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF
BREAST CANCER*

*In this article were done results of complex treatment of
patients with advanced breast cancer. We received increased*

*of pathomorphosis on 17,6% in based group. Then we
received increased of common survival and survival without
disease on 5% and 10,9%.*

*Keywords—locally advanced breast cancer, surgery,
overall and disease-free survival.*